ONEMA-POP-046 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-046 — Acolhimento e Segurança diante de Suspeita
de Surto Psicótico Agudo

1. Identificação institucional

técnica

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a atuação de enfermagem em: Acolhimento e Segurança diante de Suspeita de Surto Psicótico Agudo. Aplicável a visitas e/ou triagem digital conforme pertinência, sem substituir serviço de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, treinado e autorizado; Suspeita de psicose aguda, agitação ou alteração importante de comportamento; excluir delirium, intoxicação e causas clínicas. Não realizar intervenções além da competência, prescrição ou recursos disponíveis.

4. Materiais e equipamentos; fornecimento

Enfermeiro: telefone de emergência, equipamento de sinais vitais se presencial, ambiente com rota de saída; cuidador: histórico de medicações. Equipamentos de avaliação clínica de uso profissional são providos pelo enfermeiro; consumíveis do paciente conforme contratação.

5. Avaliação clínica e preparação

Nível de consciência, desorientação, febre, hipoglicemia possível, uso de substâncias, alucinações, delírios e risco de violência/autoagressão. Confirmar identificação, consentimento, privacidade e localização para eventual emergência.

6. Execução técnica individualizada

1. Avaliar segurança do ambiente e manter distância física apropriada, com saída livre.

2. Falar calmamente, apresentar-se, usar frases curtas e evitar confrontar crenças delirantes.

3. Verificar responsividade, sinais de delirium, intoxicação, abstinência e condições clínicas urgentes.

4. Perguntar objetivamente sobre risco de ferir a si ou a terceiros e disponibilidade de meios.

5. Se risco iminente, mobilizar equipe de emergência/SAMU 192 e apoio seguro, sem tentar contenção isolada.

6. Evitar toque não consentido, discussão, ameaças ou administração de sedativos sem prescrição/estrutura.

7. Se estável, articular avaliação presencial urgente de saúde mental e apoio de pessoa confiável.

8. Registrar observações objetivas, falas relevantes, riscos, contatos e encaminhamento.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Agressividade com risco iminente, confusão aguda, rebaixamento, intoxicação ou autoagressão: emergência.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar família a reduzir estímulos, não confrontar e buscar suporte especializado.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação, data/hora, modalidade, consentimento, queixa, avaliação, achados positivos/negativos, etapas realizadas, intervenções não realizadas e justificativa, comunicação com RT/rede, encaminhamento, orientações, plano de retorno e assinatura do enfermeiro.

10. Referências específicas e rastreáveis

 OMS — mhGAP Intervention Guide v2.0, avaliação e manejo de psicose/agitação —

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/250239/9789241549790-eng.pdf

 COFEN — Resolução 736/2024, Processo de Enfermagem —

https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

Referências consultadas como suporte temático; a correspondência exaustiva entre cada passo e a evidência, bem como regras

locais e manuais dos fabricantes, requer análise pelo RT.